Análisis del caso

1. Información personal
    - Nombre: Carlos.
    - Género: Masculino.
    - Edad: 60 años.
    - Situación Laboral: Jubilado.
    - Dirección e información de contacto: No especificado en el caso.
    - Regímenes de tratamiento: Terapia física (fortalecimiento), terapia ocupacional (independencia) y terapia del lenguaje (comunicación).

2. Financiamiento
    - Fuentes de financiamiento: A evaluar (se debe consultar si cuenta con seguro de salud o financiamiento particular para el equipo).
    - Aseguradora: No especificado en el caso.
    - Prioridad de elementos: Alta (dispositivos para comunicación y prevención de úlceras por presión) y media (apoyos para independencia en actividades de la vida diaria (AVD)), Se observan alternativas de gestión mediante seguros, ONGs o el desarrollo de soluciones de biodiseño de bajo costo.

3. Diagnósticos e historial médico
    - Diagnóstico Principal: Accidente cerebrovascular (ACV) isquémico en el hemisferio derecho.
    - Síntomas reportados: Debilidad en el lado izquierdo del cuerpo (hemiparesia), dificultad para hablar y pérdida de visión en el ojo izquierdo.
    - Pronóstico: Rehabilitación intensiva para recuperar función motora y comunicación.

4. Estado psicosocial
    - Interacción y cognición: Dificultad en la comunicación y comprensión del lenguaje.
    - Motivación: El paciente tiene la meta de regresar a sus actividades recreativas en un plazo de 6 meses.
    - Sistema de apoyo: Requiere evaluación de la dinámica familiar para el soporte en casa.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético
    - Músculos: Debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Requiere fortalecer tronco y miembros.
    - Postura: Necesidad de evaluar el equilibrio al sentarse y estar de pie debido a la lesión cerebral derecha.
    - Rango de Movimiento (ROM): Afectado en el lado izquierdo; se busca mejorar la movilidad.

6. Afección de la piel
    - Riesgos: Riesgo de úlceras por presión debido a la movilidad reducida en el lado izquierdo.
    - Estado: Se deben monitorear puntos de presión, especialmente si utiliza silla de ruedas o permanece mucho tiempo sentado.

7. Función sensorial: Habla, lenguaje y comunicación
    - Visión: Pérdida de visión funcional en el ojo izquierdo.
    - Percepción: Posible afectación de la propiocepción y tacto en el lado izquierdo debido a la ubicación de la lesión cerebral.

    - Habla, lenguaje y comunicación:
        - Dificultad para hablar y retos en la comprensión del lenguaje.
        - Necesidad de evaluar dispositivos generadores de habla o estrategias de comunicación aumentativa.

8. Desempeño funcional, de habilidades y de tareas
    - AVD: Dependencia actual en cuidado personal, vestido e higiene.
    - Alimentación: Requiere evaluación de posicionamiento y posibles cubiertos adaptados por la debilidad manual izquierda.

9. Movilidad personal
    - Ambulación: Afectada por la debilidad motora.
    - Traslados: Requiere asistencia o equipo para transferencias seguras (cama, silla, baño).

10. Transporte comunitario
    - Necesidad de evaluar la capacidad de ingreso/salida de vehículos (taxi, autobús) dada la limitación visual y motora.

11. Entornos
    - Se debe analizar si el hogar y los sitios de recreación cuentan con rampas, iluminación adecuada para su visión reducida y ausencia de peligros de caída.

12. Historial de equipos anteriores
    - Se desconoce del uso de alguna tecnología o ayuda

13. Equipo actual
    - Requerimiento: Identificar el apoyo tecnológico más relevante para cerrar la brecha de sus capacidades actuales.

Resumen de la información del paciente

a) **Usuario/Paciente: Describe las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad (caso asignado).**
   Carlos, paciente de 60 años que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en el hemisferio derecho, presenta debilidad en el lado izquierdo del cuerpo, dificultad para el habla y pérdida de visión en el campo visual izquierdo, lo que limita su independencia en actividades cotidianas. Sin embargo, conserva capacidades como el control motor del lado derecho y un estado cognitivo que le permite participar en procesos de rehabilitación
b) **Actividad: Describe el conjunto de tareas a realizar por la persona con discapacidad(caso asignado).**
   El paciente debe realizar actividades enfocadas principalmente en la rehabilitación motora del lado izquierdo, incluyendo ejercicios de movilidad articular, fortalecimiento muscular y reeducación del movimiento para evitar rigidez y pérdida funcional. Además, debe trabajar en actividades de la vida diaria como vestirse, alimentarse e higiene personal. También requiere terapias de lenguaje y ejercicios cognitivos orientados a mejorar la comunicación y funciones como la memoria y la atención.
c) **Contexto: Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad.**
   El paciente se desarrolla en un entorno que requiere adaptaciones físicas para reducir el riesgo de caídas debido a su debilidad y alteraciones visuales. Además, existe una dependencia parcial de familiares o cuidadores, lo cual influye en su proceso de recuperación. También se consideran factores emocionales y sociales, ya que su condición puede afectar su interacción y calidad de vida.
d) **Tecnología: dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno**
   Para apoyar la recuperación del paciente, se pueden emplear tecnologías como dispositivos de rehabilitación motora, estimulación eléctrica funcional y sistemas de biofeedback que permitan corregir movimientos en tiempo real. También pueden utilizarse terapias basadas en realidad virtual, aplicaciones para rehabilitación del lenguaje y herramientas de monitoreo remoto. Estas tecnologías ayudan a reducir la brecha entre sus capacidades actuales y las demandas del entorno, favoreciendo su rehabilitación progresiva.

* NOTA: esto creo que va en el git, como el readme, pero en una parte que sea sobre el caso específicamente, algo como esta en la captura de pantalla.

Files

main

Go to file

- Entregable 1
- Entregable 10
- Entregable 11
- Entregable 12
- Entregable 2
  - Caso Clínico Vargas.md
- Entregable 3
- Entregable 4
- Entregable 5
- Entregable 6
- Entregable 7
- Entregable 8
- Entregable 9
- Ficha de detalles de la invención
- HITO N°2
- Hito N°.1
- Poster
- Presentacion
- Taller OnShape
- Taller de elementos mecánicos
- README.md

Preview | Code | Blame 126 lines (97 loc) · 5.15 KB

Raw

Caso Clínico Vargas

Análisis del caso

Información Personal

- **Paciente:** Vargas Tarazona Álice
- **Edad:** 10 años (nacida el 03/12/2014)
- **Sexo:** Femenino
- **Historia Clínica:** 444673
- **DNI:** 78869410
- **Fuente de referencia:** Instituto de Salud del Niño – Breña, referida al Departamento de Trastornos Posturales.
- **Médicos y especialistas:** genética, traumatología, oftalmología, psiquiatría, psicología, endocrinología, nefrología, nutrición, cardiología, neumología.
- **Motivo de referencia:** dolor en miembros inferiores, parestesias nocturnas, alteración de la marcha y del lenguaje.
- **Tratamientos:** controles multidisciplinarios, terapias física, ocupacional, psicología, aprendizaje, servicio social.

Financiamiento

- Cuenta con certificado de discapacidad emitido.
- Atendida en hospitales nacionales (INSN Breña, INR), con acceso a interconsultas y dispositivos prescritos (plantillas ortopédicas, órtesis nocturnas, silla de ruedas, bastón canadiense).
- El financiamiento depende del sistema público de salud y apoyo familiar.

Diagnóstico e historial médico

- **Diagnóstico principal:** Enfermedad de Camurati–Engelmann (Q78.3).
- **Diagnóstico secundario:** Pie plano valgo (M21.4).

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.